REF : 008.4 - MODULE 3 — FORMATION COMMERCIALE

COMPRENDRE LE FINANCEMENT DES ÉTABLISSEMENTS

Du besoin médical à l'opportunité commerciale

Après avoir identifié QUI décide, comprenons COMMENT le besoin peut être financé.

POURQUOI UN COMMERCIAL DOIT-IL COMPRENDRE LE FINANCEMENT ?

BESOIN
L'établissement peut manquer de médecins.

BUDGET
Il faut comprendre comment ce besoin peut être financé.

DÉCIDEUR
Il faut identifier qui peut mobiliser ou arbitrer le budget.

URGENCE
Plus le problème est critique, plus le projet devient prioritaire.

L'ÉQUATION COMMERCIALE

BESOIN + BUDGET + DÉCIDEUR + URGENCE = OPPORTUNITÉ COMMERCIALE

COMMENT SE FINANCE UN EHPAD ?

Trois sections tarifaires — trois logiques de financement distinctes.

SOINS

DOTR

Financés par l'Assurance maladie / branche autonomie.

· Temps médical
· Personnels soignants
· Organisation des soins

DÉPENDANCE / AUTONOMIE

Accompagnement lié à la perte d'autonomie.

· Aides à la vie quotidienne
· Adaptation à la perte d'autonomie

HÉBERGEMENT

Hébergement et vie quotidienne.

· Restauration
· Locaux
· Animation
· Services hôteliers

POUR DOTR — c'est principalement ici, dans la section **SOINS**, que commence notre réflexion.

TARIF GLOBAL OU TARIF PARTIEL ?

Deux modèles de financement du forfait soins.

TARIF GLOBAL

Enveloppe soins plus importante.

L'établissement prend en charge davantage de dépenses médicales et paramédicales dans son propre budget.

la sécurité sociale verse un montant forfaitaire.
L'EHPAD paye les généralistes, infirmières et kiné. Le résident paie les spécialistes

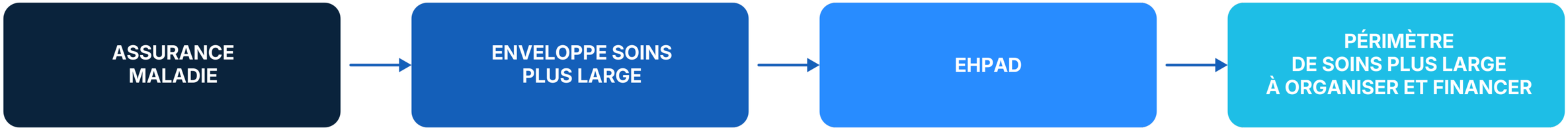
TARIF PARTIEL

Enveloppe soins plus limitée.

Une part plus importante des prestations est financée hors budget direct de l'établissement.
l'EHPAD ne paye que le personnel soignant interne
Résidents continuent à s'acquitter de leurs frais médicaux personnels comme à domicile. Ils paient directement leur consultation à leur médecin traitant, leur spécialiste, leurs médicaments. Ils sont ensuite remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, comme à domicile

Le besoin médical peut être identique.
C'est la mécanique de financement qui change.

TARIF GLOBAL — UNE ENVELOPPE PLUS LARGE, MAIS AUSSI PLUS DE RESPONSABILITÉS



PÉRIMÈTRE COUVERT PAR L'ENVELOPPE

Temps médical	Certaines interventions	Prestations paramédicales	Coordination	Organisation médicale

À RETENIR

Plus de financement ne signifie pas plus d'argent libre.

Cela signifie aussi davantage de dépenses à couvrir.

AVOIR LE BUDGET NE VEUT PAS DIRE AVOIR LE MÉDECIN

BUDGET DISPONIBLE

Temps médical budgété

≠

RESSOURCE MÉDICALE

Médecin réellement présent

SITUATIONS RÉCURRENTES SUR LE TERRAIN

- Poste médical vacant
- Médecin coordonnateur manquant
- Difficultés de recrutement
- Territoire sous-doté
- Vacations insuffisantes
- Turn-over
- Rupture de continuité médicale

« J'ai prévu du temps médical…
mais je ne trouve personne. »

SIGNAL COMMERCIAL DOTR

TRÈS FORT

TARIF GLOBAL = CIBLE NATURELLE P1

L'équation qui transforme un contexte tarifaire en priorité commerciale.



MESSAGE COMMERCIAL

DOTR transforme la capacité budgétaire en **capacité médicale disponible.**

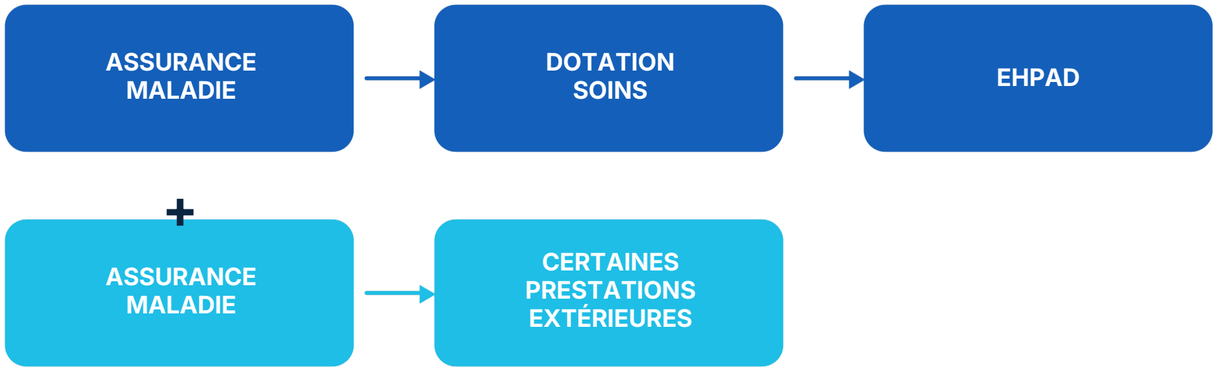
Une organisation médicale structurée : distanciel, présentiel, médecin référent, coordination et accompagnement des équipes.

Distanciel	**Présentiel**	**Médecin référent**	**Coordination**	**Accompagnement équipes**

TARIF PARTIEL — UN MODÈLE DIFFÉRENT, PAS UNE MAUVAISE CIBLE

- L'EHPAD dispose d'un budget soins mais avec une enveloppe plus limitée.
- Périmètre de dépenses supportées plus restreint.
- Une partie des prestations est financée hors budget direct, par l'Assurance maladie.

DEUX CIRCUITS DE FINANCEMENT



TARIF PARTIEL ≠ absence de financement.

LE BESOIN MÉDICAL NE DISPARAÎT PAS PARCE QUE L'ÉTABLISSEMENT EST AU TARIF PARTIEL

- **25 résidents sans médecin traitant**
- **Délais d'accès aux soins**
- **Difficultés de consultations**
- **Passages aux urgences évitables**
- **Équipes sous pression**
- **Manque de coordination**
- **Territoire sous-doté**
- **Ruptures de parcours**

LE BESOIN EXISTE.

Notre travail commercial consistealorsàidentifierCOMMENTconstruirele financement de la réponse.

GLOBAL VS PARTIEL

	TARIF GLOBAL	TARIF PARTIEL
Enveloppe soins	Plus large	Plus limitée
Périmètre	Plus large	Plus restreint
Besoin médical	Important	Peut être tout aussi important
Enjeu principal	Transformer budget en ressource médicale	Identifier / construire financement
Approche DOTR	Couvrir besoin budgété	Construire réponse au besoin
Priorité	P1 naturelle	Cible à qualifier

LE TARIF CHANGE NOTRE APPROCHE COMMERCIALE.

PAS LA RÉALITÉ DU BESOIN.

CAS N°1 — EHPAD AU TARIF GLOBAL

Contexte d'un établissement au tarif global avec ressource médicale manquante.

SITUATION

- 100 résidents
- Poste médecin non pourvu depuis plusieurs mois
- Temps médical budgété mais difficile à couvrir
- Équipes sous tension

INDICATEURS

BESOIN	OUI
BUDGET	IDENTIFIÉ
RESSOURCE	MANQUANTE
URGENCE	FORTE

VERDICT

P1 — PRIORITÉ COMMERCIALE

QUESTION CLÉ

Quel temps médical est aujourd'hui budgété mais non couvert ?

CAS N°2 — EHPAD AU TARIF PARTIEL

Contexte d'un établissement au tarif partiel avec besoin fort.

SITUATION

- 90 résidents
- 20 à 25 résidents sans médecin traitant
- Difficultés d'accès aux soins
- Équipes cherchent solutions au cas par cas

INDICATEURS

BESOIN	FORT
BUDGET	À INVESTIGUER
RESSOURCE	INSUFFISANTE
URGENCE	FORTE

VERDICT

NE PAS ÉLIMINER LE LEAD

QUESTION CLÉ

Comment financez-vous aujourd'hui ce besoin et quelles enveloppes pourraient être mobilisées pour construire une réponse ?

PUBLIC ≠ PAS DE BUDGET

Trois logiques institutionnelles distinctes — trois cycles de vente différents.

PUBLIC

- Financement encadré
- Processus décisionnel institutionnel
- Possibilité de financements publics
- Cycle plus long

ASSOCIATIF / NON LUCRATIF

- Budgets médico-sociaux
- Organisme gestionnaire
- CPOM
- Décision établissement + siège

PRIVÉ COMMERCIAL

- Budget soins + groupe
- Décision plus directe
- Logique performance / ROI / organisation

Le statut juridique change le processus de vente.
Il ne détermine pas à lui seul le potentiel commercial.

LE FORFAIT SOINS N'EST PAS LE SEUL LEVIER

Panorama des enveloppes complémentaires à investiguer avec le prospect.

CPOM

Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Priorités : accès aux soins, coordination, organisation médicale.

ARS

Crédits et dispositifs liés aux priorités territoriales.

FINANCEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Crédits selon dispositifs et projets spécifiques.

FIR

Fonds d'intervention régional selon priorités ARS.

APPELS À PROJETS / AMI

Innovation, accès aux soins, prévention, numérique, transformation de l'offre.

SIÈGE / GROUPE

Investissement ou arbitrage par l'organisme gestionnaire.

Aucun de ces financements n'est automatique : **le commercial doit les investiguer.**

PUBLIC + PARTIEL :
NE PAS DIRE NON TROP VITE

FICHE PROSPECT

01 EHPAD PUBLIC

02 TARIF PARTIEL

03 FORT DÉSERT MÉDICAL

04 RÉSIDENTS SANS MÉDECIN

05 DIRECTION MOBILISÉE

MAUVAIS LEAD ?

NON.

Besoin fort = opportunité à investiguer.

POINTS À VÉRIFIER

- Budget disponible
- CPOM
- Crédits ARS
- Financements complémentaires
- Organisme gestionnaire

NOTRE MATRICE DE PRIORISATION

P1

PRIORITÉ

Besoinfort+financement identifié + décideur accessible + urgence.

P2

À DÉVELOPPER

Besoinfort+financementàconstruire + décideur identifié.

P3

À NOURRIR

Besoinfaibleounonqualifié + pas de projet immédiat.

GLOBAL peut être P1. PARTIEL peut être P1 ou P2. PUBLIC peut être P1 ou P2.
On ne classe jamais uniquement selon le statut ou le tarif.

LES QUESTIONS À POSER EN RENDEZ-VOUS

10 questions structurées pour qualifier un établissement.

1. Êtes-vous en tarif global ou partiel ?
2. Quelle est votre organisation médicale actuelle ?
3. Quel temps médical est prévu / budgété ?
4. Quel temps médical est réellement couvert ?
5. Quels professionnels vous manquent aujourd'hui ?
6. Combien de résidents sont concernés ?
7. Comment financez-vous actuellement ce besoin ?
8. Disposez-vous de financements complémentaires ou d'un axe CPOM lié à l'accès aux soins ?
9. Le siège ou l'ARS peuvent-ils intervenir ?
10. Qui décide de l'utilisation de cette enveloppe ?

COMPRENDRE AVANT DE PROPOSER.

LES PHRASES QUI DOIVENT DÉCLENCHER UNE ALERTE COMMERCIALE

« *Nous n'arrivons plus à recruter de médecin.* »

« *Notre médecin coordonnateur est parti.* »

« *Plusieurs résidents n'ont plus de médecin traitant.* »

« *Nous avons du budget mais aucun candidat.* »



« *L'ARS nous demande de travailler sur l'accès aux soins.* »

« *C'est prévu dans notre CPOM.* »

« *Nous sommes obligés d'envoyer trop souvent les résidents aux urgences.* »

« *Nos équipes passent énormément de temps à chercher des médecins.* »

LE RÉFLEXE DOTR

NE DEMANDEZ PLUS SIMPLEMENT :

« Avez-vous du budget ? »

DEMANDEZ PLUTÔT

« Comment financez-vous aujourd'hui le besoin médical que vous n'arrivez pas à couvrir ? »

BESOIN → FINANCEMENT → DÉCIDEUR → SOLUTION DOTR

CE QU'IL FAUT RETENIR

01
TARIF GLOBAL

Cible naturelle P1.

02
TARIF PARTIEL

Vraie cible. Financement différent, besoin potentiellement identique.

03
PUBLIC

Cycle de vente différent, mais opportunité réelle.

04
QUALIFICATION

Besoin + Budget + Décideur + Urgence.

MESSAGE FINAL

NE QUALIFIEZ JAMAIS UN ÉTABLISSEMENT UNIQUEMENT SUR SON TARIF OU SON STATUT.

Qualifiez son besoin médical et sa capacité à construire une solution.